جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فرغلية يوسف محمد يوسف

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** =

رقم البطاقة : 28311242400527 **رقم التليفون :** 01284296341 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 24-11-1983**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ---

خطة العلاج : ---

المستشفي : --- **قسم :** ---

جهة العلاج : --- **نفقات :** ---

ملاحظات : ---

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: فرغلية يوسف محمد يوسف
National ID: 28311242400527

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

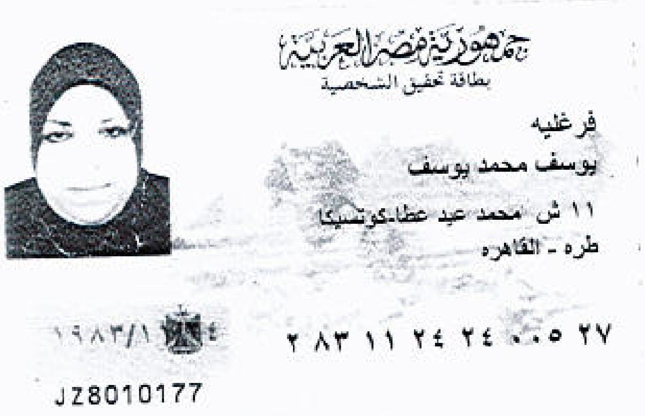
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فرغليه
يوسف محمد يوسف
١١ ش محمد عيد عطا-كوتسيكا
طره - القاهره

١٩٨٣/١ ٤

٢ ٨٣ ١١ ٢٤ ٢٤ ٠٠٥ ٢٧

JZ8010177

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

٢٨٣١١٢٤٢٤٠٠٥٦٧ ٢٠٢٣/٠٥
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
ايمن شعبان عبد العزيز اسماعيل
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٥/٢٣

National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Pathology Report

Name فرغليه يوسف مجيد

Age: 36 years.

Clinical data: breast mass

Specimen type: tru-cut biopsy

Date: 21/11/2019

Lab. Number: 1232

Hospital Number: /2019

Gross Description:

Multiple grayish white cores, longest is 1.3 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of cores received revealed malignant growth formed invasive cords, clusters and tubules of moderately anaplastic ductal epithelial cells, fair desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Breast mass, core biopsy; Invasive duct carcinoma GII.

for IHC; (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Lubna Omar

Prof. Dr. Essam Ayad

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: قرنفلة يوسف احمد

Age:

Hospital number.:

Date: 7/7/2020

telephone

01284296341

MDT FORM

Clinical data:

36 y female ER -ve PR -ve HER II +ve

[illegible] to N1 (10/20

NACh (without her

ge

T0 N1 Partial Re.

Partial Response

for adjuvant therapy

MDT

MDT Outcome and Plan:

(margin (Medial showing foci of DCIS)

→ For Wider Excision

± Frozen section

26/7/2020 ⇒ Rexcision → Margins free tiny Re & DCIS

For consult Regarding Adjuvant

Signature:

Surgical oncology **Radiation oncology** **medical oncolo**

MDT-Form
[DOCTYPE:MDT-FORM]

مركز أورام دار السلام
هرمل سابقا

Name : **Farghalia Yousef Mohamed** **Date :** **27-07-202**

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST :-

A known case of right breast cancer.

- Status post right BCS with underlying seroma measuring ab 6x3.5 cm with overlying skin thickening measuring about 9 mm.
- Right axillary soft tissue density is seen measuring about 5x3.5 likely postoperative sequel.
- Apart from right middle lung lobe and left upper lung lobe lingu segment atelectatic bands, no sizable pulmonary nodules, mass areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses se
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vesse
- Mild dorsal spondylotic changes are seen.
- Upper abdominal cuts show multiple gall bladder stones and fa hepatomegaly.

OPINION:

- ***Status post right BCS with underlying seroma overlying skin thickening.***
- ***Right axillary soft tissue density likely postopera sequel.***

Dr. Reham Anwar, MSc, FEBR
Dr.m.gomaa,md

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[illegible]

Name : FARGHALYA YOUSUF

Date : 14-05-2020

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHE ABDOMEN & PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -

Chest:

- ➢ Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas consolidation or cavitary lesions.
- ➢ No hilar or mediastinal lymph nodes.
- ➢ No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- ➢ Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the carc chambers. No pericardial effusion detected.
- ➢ Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen:

- ➢ The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions contour irregularities.
- ➢ Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as main tributaries.
- ➢ Innumerable small gall stones are noted.
- ➢ No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- ➢ Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- ➢ Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones back-pressure changes.
- ➢ Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- ➢ Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticu outpouching.
- ➢ Normal appearance of the other pelvic organs.
- ➢ No abdominal or pelvic masses or collections.
- ➢ Reviewing skeletal parts revealed no lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

- ➢ *No CT evidence of pulmonary nodules or hepatic focal lesions.*
- ➢ *Calcular gall bladder.*
- ➢ *No lytic or sclerotic osseous lesions.*

DR. Ibrahim Elsedawy.M.Sc, FEBR

Dr.m.gomaa, md

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Radiology Department دار السلام الأشعة

Name: FARGHALIA YOSIF MOHAMED
Date: 26 November 2019

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALE

Liver: -

- *Mildly enlarged in size (about 16.8 cm at the right MCL), smooth outlin bright echopattern.*
  No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- *Portal vein is not dilated and patent .*

Gall Bladder: -

- *Contracted upon multiple stones.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size (About 10 cm), displaying homogenous echopattern.*

Kidneys: -

Are of normal size , site , well differentiated & with no gross stones or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

-Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

-No ascites .

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones, masses or diverticular out pouching*

Uterus and adnexa:- *no abnormalities could be detected*

Opinion:

Bright enlarged liver likely fatty.
Calcular contracted GB.

Best regards
Dr: Doaa Ahmed Abdel
MSc, FEBR

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

مركز الأورام

Nasser Institute Hospital

اصر

أورام

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

الطب النووي

Patient Name: Farghalia Yousef Yousef.
Referring physician: Prof.

Date: 6/6/2020

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected allo the surveyed skeleton.
- Degenertaive changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are seen

Conclusion:

- No definite evidence of metatstatic osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear Medicine

Hud Fathy, MD

Walid Omar, M.D.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]